ΜΠΟΝΟΥΣ 3

Πρότυπα Παρουσίασης Περιστατικού στην Επίσκεψη

Δομή παρουσίασης 60 και 120 δευτερολέπτων, 8 πρότυπα ανά τύπο περιστατικού, έτοιμες φράσεις που θα σας φανούν χρήσιμες στην επίσκεψη και 6 πλήρη παραδείγματα παρουσίασης από την αρχή ως το τέλος.

Περιεχόμενα

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πρότυπα

Μέρος 1 · Παρουσίαση 60 δευτερολέπτων

Μέρος 2 · Παρουσίαση 120 δευτερολέπτων

Μέρος 3 · 8 πρότυπα ανά τύπο περιστατικού

Μέρος 4 · Φράσεις που βοηθούν στην επίσκεψη

Μέρος 5 · 6 παραδείγματα παρουσίασης

Μέρος 6 · Τελικός έλεγχος πριν από την παρουσίαση

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πρότυπα

Μια καλή παρουσίαση περιστατικού είναι μια καλή γνωμάτευση ειπωμένη φωναχτά: ίδια σειρά, ίδια σαφήνεια.

> *Αυτό που σας δυσκολεύει στην επίσκεψη συνήθως δεν είναι η έλλειψη γνώσεων, αλλά ότι χάνετε τη σειρά. Το πρότυπο κρατά τη σειρά για εσάς· εσείς εστιάζετε στο εύρημα.*

Η παρουσίαση είναι ίδια με **τη μέθοδο των 4 βημάτων** που χρησιμοποιείτε όταν συντάσσετε γνωμάτευση:

ΒΗΜΑ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	Ασθενής (ηλικία, φύλο), κλινικό ερώτημα, εξέταση και πρωτόκολλο, τεχνική επάρκεια.
2 · ΣΑΡΩΣΤΕ	Η φράση «Αξιολόγησα συστηματικά»· αναφέρετε σύντομα ποιες περιοχές εξετάσατε.
3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ	Κύριο εύρημα: σωστός όρος, θέση, μέγεθος, όρια· σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση. Έπειτα, τα συνοδά ευρήματα.
4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ	Συμπέρασμα σε μία φράση, διαφορική διάγνωση, σύσταση· σε ποιον και πότε αναφέρθηκε το επείγον εύρημα.

Τρεις χρυσοί κανόνες

1. **Μην κρατάτε το συμπέρασμα για το τέλος.** Ακόμη και στην παρουσίαση των 60 δευτερολέπτων, πείτε το κλινικό ερώτημα στην πρώτη φράση και το σαφές συμπέρασμα στην τελευταία.

2. **Μιλήστε ενώ δείχνετε την εικόνα.** Ενώ περιγράφετε το εύρημα, κρατήστε αυτή την τομή ανοιχτή στην οθόνη και δείξτε την.

3. **Μην επινοείτε όσα δεν γνωρίζετε.** Το να πείτε «Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα ήθελα να το αξιολογήσω μαζί με τον επιμελητή μου» είναι δείγμα επαγγελματισμού.

Εξάσκηση

Δοκιμάστε κάθε πρότυπο πρώτα φωναχτά, με χρονόμετρο, τρεις φορές. Γράψτε τον δικό σας χρόνο στο Τετράδιο Εξάσκησης· στόχος είναι να ολοκληρώνετε την παρουσίαση των 60 δευτερολέπτων σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα.

ΜΕΡΟΣ 1

Παρουσίαση 60 δευτερολέπτων

Παράδοση εφημερίας, επίσκεψη στον διάδρομο, όταν σας λένε «πείτε το σύντομα».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΙ ΛΕΤΕ
0–10 δευτ. · Ταυτότητα και ερώτημα	«[Άνδρας/Γυναίκα] [ηλικία] ετών, υποβλήθηκε σε [εξέταση] λόγω [ενοχλήματος/κλινικού ερωτήματος].»
10–15 δευτ. · Τεχνική	«Η εξέταση είναι διαγνωστικής ποιότητας.» ή «Λόγω [περιορισμού] η αξιολόγηση είναι περιορισμένη.»
15–40 δευτ. · Κύριο εύρημα	«Στ[ην/ο] [θέση] παρατηρείται [εύρημα] [μέγεθος], [όρια], [πυκνότητα/σήμα/ηχογένεια]. Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση: [μεταβολή].»
40–50 δευτ. · Συνοδά ευρήματα	«Συνοδό [εύρημα] υπάρχει / δεν υπάρχει. Δεν παρατηρείται [σημαντικό αρνητικό εύρημα].»
50–60 δευτ. · Συμπέρασμα	«Συμπερασματικά, συμβατό με [διάγνωση]· στη διαφορική διάγνωση [1–2 διαγνώσεις]. [Σύσταση]. [Ενημερώθηκε η κλινική ομάδα].»

Το μυστικό για να μείνετε σύντομοι

Σε 60 δευτερόλεπτα αναφέρετε μόνο ένα κύριο εύρημα και το πολύ δύο σημαντικά αρνητικά ευρήματα. Τα υπόλοιπα, αναπτύξτε τα αν σας ρωτήσουν.

ΜΕΡΟΣ 2

Παρουσίαση 120 δευτερολέπτων

Πρωινή επίσκεψη, συνάντηση περιστατικών, η στιγμή που ο επιμελητής σας λέει «πείτε το από την αρχή».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΙ ΛΕΤΕ
0–15 δευτ. · Ταυτότητα και κλινική εικόνα	Ηλικία, φύλο, ενόχλημα και διάρκειά του, σχετικό ιστορικό, κλινικό ερώτημα.
15–25 δευτ. · Εξέταση και τεχνική	Μέθοδος, σκιαγραφικό και φάση (ή ακολουθίες), τεχνική επάρκεια, ύπαρξη προηγούμενων εξετάσεων.
25–35 δευτ. · Σάρωση	«Αξιολόγησα συστηματικά [τις περιοχές].»
35–75 δευτ. · Κύριο εύρημα	Πλήρης περιγραφή με τον σωστό όρο: θέση, μέγεθος (σε δύο ή τρία επίπεδα), όρια, εσωτερική δομή, σκιαγραφική ενίσχυση· σύγκριση.
75–90 δευτ. · Συνοδά και αρνητικά ευρήματα	Επιπλοκές, συνοδά ευρήματα, σημαντικά αρνητικά ευρήματα σχετικά με το κλινικό ερώτημα.
90–110 δευτ. · Συμπέρασμα και διαφορική διάγνωση	Συμπέρασμα σε μία φράση· γιατί σκεφτήκατε πρώτα αυτό στη διαφορική διάγνωση.
110–120 δευτ. · Σύσταση και επικοινωνία	Σύσταση περαιτέρω διερεύνησης ή παρακολούθησης· αν πρόκειται για επείγον εύρημα, σε ποιον και πότε αναφέρθηκε.

Συχνό λάθος

Στην παρουσίαση των 120 δευτερολέπτων ο περισσότερος χρόνος χάνεται στη φράση της σάρωσης. Μην απαριθμείτε ένα ένα τα φυσιολογικά όργανα: αρκεί να πείτε «Τα υπόλοιπα συμπαγή όργανα χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα»· τα σημαντικά αρνητικά ευρήματα που σχετίζονται με το κλινικό ερώτημα, όμως, αναφέρετέ τα χωριστά.

ΜΕΡΟΣ 3

8 πρότυπα ανά τύπο περιστατικού

Συμπληρώστε τα κενά, μην αλλάζετε τη σειρά.

ΠΡΟΤΥΠΟ 1

Επείγον εύρημα (π.χ. αιμορραγία, πνευμοθώρακας, ελεύθερος αέρας)

1. «Ξεκινώ με ένα επείγον εύρημα: [εύρημα].»
2. Ασθενής, κλινικό ερώτημα, εξέταση.
3. Θέση, μέγεθος και επίδραση του ευρήματος (π.χ. επίδραση μάζας, μετατόπιση, σύμπτωση).
4. Επιπλοκές και συνοδά ευρήματα.
5. «Στις [ώρα] ενημερώθηκε [η κλινική ομάδα/ο ιατρός].»

ΠΡΟΤΥΠΟ 2

Φυσιολογική εξέταση

1. Ασθενής, κλινικό ερώτημα, εξέταση και τεχνική επάρκεια.
2. «Στη συστηματική αξιολόγηση δεν διαπίστωσα παθολογικά ευρήματα.»
3. Σημαντικά αρνητικά ευρήματα σχετικά με το κλινικό ερώτημα (π.χ. «δεν παρατηρείται αιμορραγία, επίδραση μάζας ή κάταγμα»).
4. Αν η εξέταση έχει περιορισμούς, αναφέρετέ τους (π.χ. η πρώιμη ισχαιμία μπορεί να μη φαίνεται στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό).
5. Σύσταση, αν χρειάζεται.

ΠΡΟΤΥΠΟ 3

Μάζα / βλάβη

1. Ασθενής, κλινικό ερώτημα, εξέταση και φάσεις σκιαγραφικού.
2. Θέση, μέγεθος, όρια, εσωτερική δομή και συμπεριφορά σκιαγραφικής ενίσχυσης της βλάβης.
3. Σχέση με τις γειτονικές δομές, σημεία διήθησης.
4. Λεμφαδένες και απομακρυσμένα ευρήματα.
5. Διαφορική διάγνωση (ξεκινώντας από την πιθανότερη) και σύσταση περαιτέρω διερεύνησης.

ΠΡΟΤΥΠΟ 4

Λοίμωξη / φλεγμονή

1. Ασθενής, κλινική εικόνα (πυρετός, πόνος, εργαστηριακά αν υπάρχουν), εξέταση.
2. Κύριο φλεγμονώδες εύρημα: θέση, έκταση.
3. Επιπλοκή: απόστημα, διάτρηση, απόφραξη, επέκταση.
4. Διαφορική διάγνωση.
5. Σύσταση (υπάρχει συλλογή κατάλληλη για παροχέτευση; χρειάζεται παρακολούθηση;).

ΠΡΟΤΥΠΟ 5

Τραύμα

1. Ασθενής, μηχανισμός κάκωσης, εξέταση.
2. Πρώτα η σοβαρότερη κάκωση (εύρημα απειλητικό για τη ζωή).
3. Άλλες κακώσεις, με συστηματική σειρά (από πάνω προς τα κάτω ή όργανο προς όργανο).
4. Σημαντικά αρνητικά ευρήματα (π.χ. «δεν παρατηρείται ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού»).
5. Αναφορά και σύσταση.

ΠΡΟΤΥΠΟ 6

Εξέταση παρακολούθησης (συγκριτική)

1. Ασθενής, γνωστή διάγνωση, ημερομηνία και απεικονιστική μέθοδος της προηγούμενης εξέτασης.
2. Σημερινή μέτρηση της γνωστής βλάβης και μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη (με την ίδια μέθοδο μέτρησης).
3. Υπάρχει νέο εύρημα;
4. Συνολική εκτίμηση: υποστροφή, σταθερή εικόνα, εξέλιξη.
5. Σύσταση.

ΠΡΟΤΥΠΟ 7

Έλεγχος σωλήνα / καθετήρα / συσκευής

1. Ασθενής, εξέταση, συσκευή/-ές που ελέγχθηκαν.
2. Πού βρίσκεται το άκρο κάθε συσκευής· είναι στην αναμενόμενη θέση;
3. Επιπλοκή σχετιζόμενη με τη συσκευή (πνευμοθώρακας, λανθασμένη θέση, αναδίπλωση).
4. Μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη ακτινογραφία.
5. Αν η θέση δεν είναι η ενδεδειγμένη, αναφορά.

ΠΡΟΤΥΠΟ 8

Τυχαίο εύρημα

1. Πρώτα το κλινικό ερώτημα και η απάντησή του.
2. «Επιπλέον, ως τυχαίο εύρημα παρατηρήθηκε [εύρημα].»
3. Περιγραφή του ευρήματος.
4. Κλινική σημασία και σύσταση σύμφωνα με την προσέγγιση παρακολούθησης που χρησιμοποιεί το τμήμα σας.
5. Υπήρχε σε προηγούμενες εξετάσεις;

ΜΕΡΟΣ 4

Φράσεις που βοηθούν στην επίσκεψη

Η σωστή φράση μεταφέρει το σωστό επίπεδο βεβαιότητας.

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ	ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
Έναρξη	«[Άνδρας/Γυναίκα] [ηλικία] ετών· υποβλήθηκε σε [εξέταση] λόγω [κλινικού ερωτήματος].»
Τεχνικός περιορισμός	«Λόγω τεχνημάτων κίνησης η αξιολόγηση της περιοχής [περιοχή] είναι περιορισμένη.»
Σύγκριση	«Σε σύγκριση με την [εξέταση] της [ημερομηνία], το [εύρημα] έχει [αυξηθεί/μειωθεί/παραμείνει αμετάβλητο] ως προς [μέγεθος/εικόνα].»
Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση	«Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.»
Υψηλή βεβαιότητα	«Συμβατό με …»
Μέτρια βεβαιότητα	«Υπέρ …· στη διαφορική διάγνωση μπορεί να εξεταστεί …»
Χαμηλή βεβαιότητα	«Δεν μπορεί να αποκλειστεί …»
Σημαντικό αρνητικό εύρημα	«Όσον αφορά το κλινικό ερώτημα, δεν παρατηρείται …»
Σύσταση	«Συνιστάται αξιολόγηση με [εξέταση] όσον αφορά …»
Αναφορά	«Το εύρημα κοινοποιήθηκε στις [ώρα] στον [αρμόδιο ιατρό].»
Ερώτηση που δεν γνωρίζετε	«Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό· θα το διαβάσω και θα σας απαντήσω στην αυριανή επίσκεψη.»
Αν ο επιμελητής σας έχει διαφορετική άποψη	«Είχα σκεφτεί … λόγω …· θα ήθελα να μάθω πώς αξιολογείτε εσείς το εύρημα ….»
Όταν ο χρόνος πιέζει	«Εν συντομία: συμβατό με …, αναφέρθηκε σε …. Θέλετε να σας δείξω τις λεπτομέρειες;»
Κλείσιμο	«Συμπερασματικά, …· η σύστασή μου είναι ….»

Εκφράσεις προς αποφυγή

- «Μάλλον υπάρχει κάτι» — πείτε το εύρημα και τη θέση του.
- «Μοιάζει φυσιολογικό» — ή είναι φυσιολογικό ή αναφέρετε τον περιορισμό.
- «Ήπιο», «σημαντικό» (χωρίς μέτρηση) — δώστε μέτρηση.
- «Όγκος» (χωρίς ιστολογική διάγνωση) — πείτε «μάζα» ή «χωροκατακτητική βλάβη».
- «Πυκνότητα» στη μαγνητική, «σκίαση» στον υπέρηχο — χρησιμοποιήστε τον όρο που ανήκει στην κάθε απεικονιστική μέθοδο.

ΜΕΡΟΣ 5

6 παραδείγματα παρουσίασης

Όλα τα περιστατικά είναι επινοημένα· έχουν δημιουργηθεί μόνο για να δείξουν τη δομή της παρουσίασης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 · 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ · ΠΡΟΤΥΠΟ 1

Αξονική εγκεφάλου μετά από τραύμα

«Ξεκινώ με ένα επείγον εύρημα: **οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα**.

Άνδρας εβδομήντα δύο ετών υποβλήθηκε σε αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό λόγω θόλωσης συνείδησης μετά από πτώση στο σπίτι. Η εξέταση είναι διαγνωστικής ποιότητας.

Κατά μήκος της αριστερής μετωποβρεγματικής κυρτότητας, παράλληλα με το έσω πέταλο του κρανίου, παρατηρείται μηνοειδής υπέρπυκνη εξωαξονική συλλογή. Υπάρχει πίεση στην αριστερή πλάγια κοιλία και μετατόπιση της μέσης γραμμής προς τα δεξιά.

Στο οστικό παράθυρο δεν διαπίστωσα κάταγμα. Δεν παρατηρείται συνοδός αιμορραγία του παρεγχύματος.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα συνάδουν με οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα με επίδραση μάζας. Το εύρημα κοινοποιήθηκε στις 03.10 στον ιατρό του ΤΕΠ.»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 · 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ · ΠΡΟΤΥΠΟ 7

Ακτινογραφία θώρακα στη μονάδα εντατικής θεραπείας

«Γυναίκα εξήντα πέντε ετών υποβλήθηκε σε προσθιοπίσθια ακτινογραφία θώρακα στο κρεβάτι για έλεγχο του σωλήνα μετά τη διασωλήνωση. Υπάρχει ήπια περιστροφή, επαρκής για αξιολόγηση.

Το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα βρίσκεται ακριβώς πάνω από το επίπεδο της τρόπιδας· πιο περιφερικά από τη θέση που αναμένει το τμήμα μας. Το άκρο του δεξιού σφαγιτιδικού κεντρικού φλεβικού καθετήρα βρίσκεται στο επίπεδο της άνω κοίλης φλέβας. Ο ρινογαστρικός σωλήνας εκτείνεται κάτω από το διάφραγμα.

Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας. Σε σύγκριση με την προηγούμενη ακτινογραφία δεν υπάρχει νέα πύκνωση.

Συμπερασματικά, ο ενδοτραχειακός σωλήνας βρίσκεται σε περιφερική θέση· συνιστάται εκτίμηση για απόσυρσή του. Ενημερώθηκε ο ιατρός της μονάδας εντατικής θεραπείας.»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 · 120 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ · ΠΡΟΤΥΠΟ 4

Κοιλιακό άλγος δεξιού κάτω τεταρτημορίου, αξονική κοιλίας

«Άνδρας είκοσι οκτώ ετών προσήλθε με άλγος δεξιού κάτω τεταρτημορίου και πυρετό διάρκειας δύο ημερών· το κλινικό ερώτημα είναι οξεία σκωληκοειδίτιδα. Υποβλήθηκε σε αξονική κοιλίας-πυέλου με σκιαγραφικό σε πυλαία φλεβική φάση· δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση. Η εξέταση είναι διαγνωστικής ποιότητας.

Αξιολόγησα συστηματικά την κοιλία: ελεύθερος αέρας, συμπαγή όργανα, έντερο, αγγεία και πύελος.

Η διάμετρος της σκωληκοειδούς απόφυσης είναι αυξημένη, το τοίχωμα παχυσμένο και ενισχύεται μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού. Στον αυλό υπάρχει υπέρπυκνη εστία συμβατή με κοπρόλιθο. Στον περισκωληκοειδή λιπώδη ιστό παρατηρείται διήθηση και μικρή ποσότητα ελεύθερου υγρού.

Δεν διαπίστωσα συλλογή συμβατή με απόστημα ούτε ελεύθερο αέρα. Το τοίχωμα του τελικού ειλεού και του τυφλού χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Ο δεξιός νεφρός και η πορεία του ουρητήρα χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα, δεν παρατηρείται λίθος.

Συμπερασματικά, η εικόνα είναι συμβατή με **μη επιπλεγμένη οξεία σκωληκοειδίτιδα** και στη διαφορική διάγνωση μπορούν να εξεταστούν η εκκολπωματίτιδα του τυφλού και η τελική ειλεΐτιδα· ωστόσο, τα ευρήματα επικεντρώνονται στη σκωληκοειδή απόφυση.

Το εύρημα κοινοποιήθηκε στον ειδικευόμενο γενικής χειρουργικής.»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 · 120 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ · ΠΡΟΤΥΠΟ 3

Μάζα πνεύμονα στην αξονική θώρακα

«Άνδρας εξήντα οκτώ ετών, με μακροχρόνιο ιστορικό καπνίσματος και βήχα διάρκειας τριών μηνών· μετά την ανεύρεση σκίασης στην ακτινογραφία θώρακα υποβλήθηκε σε αξονική θώρακα με σκιαγραφικό. Για σύγκριση υπάρχει μόνο ακτινογραφία θώρακα πριν από έναν μήνα.

Έκανα συστηματική αξιολόγηση σε πνευμονικό και μεσοθωρακικό παράθυρο.

Στον δεξιό άνω λοβό παρατηρείται συμπαγής μάζα με ανώμαλα και ακιδωτά όρια και ανομοιογενή σκιαγραφική ενίσχυση. Η μάζα αντιστοιχεί στη σκίαση της ακτινογραφίας. Υπάρχει υποψία επέκτασης στον υπεζωκότα· διήθηση του θωρακικού τοιχώματος δεν είναι εμφανής.

Στη δεξιά πύλη και στην κάτω παρατραχειακή περιοχή υπάρχουν διογκωμένοι λεμφαδένες. Στον αριστερό πνεύμονα δεν διαπίστωσα όζο. Τα επινεφρίδια και το ήπαρ που περιλαμβάνονται στο πεδίο τομής χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα· στα οστά δεν παρατηρούνται λυτικές βλάβες.

Συμπερασματικά, η εικόνα είναι συμβατή με **μάζα υπέρ πρωτοπαθούς κακοήθειας του πνεύμονα** και λεμφαδενοπάθεια πυλών-μεσοθωρακίου. Για ιστολογική διάγνωση και σταδιοποίηση συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση.

Θα ήθελα να οριστικοποιήσω τη γνωμάτευση μαζί με τον επιμελητή μου.»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 · 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ · ΠΡΟΤΥΠΟ 2

Κεφαλαλγία, φυσιολογική αξονική εγκεφάλου

«Γυναίκα σαράντα ετών υποβλήθηκε σε αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό λόγω κεφαλαλγίας διάρκειας μίας εβδομάδας. Η εξέταση είναι διαγνωστικής ποιότητας.

Στη συστηματική αξιολόγηση δεν διαπίστωσα παθολογικά ευρήματα.

Δεν παρατηρείται αιμορραγία, επίδραση μάζας ή μετατόπιση της μέσης γραμμής. Κοιλίες και δεξαμενές χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Η διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας διατηρείται. Στο οστικό παράθυρο δεν υπάρχει παθολογία· οι παραρρίνιοι κόλποι είναι καλά αεριζόμενοι.

Γνωρίζουμε ότι η αξονική χωρίς σκιαγραφικό έχει περιορισμούς στην ανάδειξη ορισμένων παθολογιών· αν η κλινική υποψία επιμένει, η περαιτέρω διερεύνηση μπορεί να εκτιμηθεί από κοινού με την κλινική ομάδα.»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 · 120 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ · ΠΡΟΤΥΠΟ 6

Παρακολούθηση ηπατικής βλάβης

«Γυναίκα πενήντα πέντε ετών, χειρουργημένη για κακοήθεια του παχέος εντέρου· υποβλήθηκε σε αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό σε πυλαία φλεβική φάση για παρακολούθηση της μοναδικής γνωστής βλάβης του ήπατος. Τη συνέκρινα με την αξονική πριν από έξι μήνες. Η εξέταση είναι διαγνωστικής ποιότητας.

Αξιολόγησα συστηματικά την κοιλία.

Η γνωστή υπόπυκνη βλάβη στον δεξιό λοβό του ήπατος, μετρούμενη με την ίδια μέθοδο και στην ίδια τομή με την προηγούμενη εξέταση, έχει μειωθεί σε μέγεθος. Τα όρια και η εσωτερική δομή της βλάβης δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά.

Δεν διαπίστωσα νέα βλάβη στο ήπαρ. Δεν παρατηρούνται ευρήματα συμβατά με λεμφαδενοπάθεια, ασκίτη ή περιτοναϊκές εμφυτεύσεις. Στην περιοχή της αναστόμωσης δεν υπάρχει εμφανής παθολογία. Στις βάσεις των πνευμόνων που περιλαμβάνονται στο πεδίο τομής δεν παρατηρούνται όζοι.

Συμπερασματικά, η γνωστή ηπατική βλάβη παρουσιάζει **μείωση μεγέθους**· δεν υπάρχει νέα βλάβη. Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση, μπορεί να εκτιμηθεί ως ανταπόκριση στη θεραπεία.

Το διάστημα παρακολούθησης μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με το πλάνο της κλινικής ομάδας.»

ΜΕΡΟΣ 6

Τελικός έλεγχος πριν από την παρουσίαση

Αφιερώστε 2 λεπτά πριν από την επίσκεψη.

Πριν από κάθε παρουσίαση

- [ ] Μπορώ να πω την ηλικία, το φύλο και το κλινικό ερώτημα του ασθενούς σε μία φράση.
- [ ] Έχω έτοιμη τη σημείωση για την εξέταση, τη φάση σκιαγραφικού ή τις ακολουθίες και την τεχνική επάρκεια.
- [ ] Άνοιξα την προηγούμενη εξέταση και έκανα σύγκριση (ή σημείωσα ότι δεν υπάρχει).
- [ ] Η τομή που δείχνει το κύριο εύρημα είναι έτοιμη στην οθόνη.
- [ ] Χρησιμοποιώ τον σωστό όρο (πυκνότητα / σήμα / ηχογένεια) για το κύριο εύρημα.
- [ ] Έχω τουλάχιστον δύο σημαντικά αρνητικά ευρήματα σχετικά με το κλινικό ερώτημα.
- [ ] Το συμπέρασμά μου σε μία φράση και η διαφορική μου διάγνωση είναι έτοιμα.
- [ ] Αν υπάρχει επείγον εύρημα, ξέρω σε ποιον και πότε αναφέρθηκε.
- [ ] Πρόβαρα την παρουσίαση μία φορά σιωπηλά, με χρονόμετρο.

Χρυσός κανόνας

Στην επίσκεψη, το μόνο που θα θυμάται ο επιμελητής σας είναι η τελευταία σας φράση. Γράψτε το συμπέρασμα της γνωμάτευσης από πριν και πείτε το λέξη προς λέξη.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Επιλέξτε τώρα ένα περιστατικό από τα 100 Πρακτικά Περιστατικά και κάντε μια παρουσίαση 60 δευτερολέπτων με χρονόμετρο, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο από τα Πρότυπα 1–8.

Για να μελετήσετε από πριν τις ερωτήσεις που θα σας κάνουν στην παρουσίαση, περάστε στις **300 Ερωτήσεις Επίσκεψης και Προφορικής Εξέτασης**.